

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬 DNA合成・細胞分裂を障害	白金製剤 シスプラチン カルボプラチン
	代謝拮抗薬・微小管阻害薬 ペメトレキセド ゲムシタビン S-1 パクリタキセル nab-パクリタキセル ドセタキセル
	トポ阻害薬(小細胞) エトポシド イリノテカン アムルビシン
EGFR・ALK阻害薬 頻度の高いドライバー遺伝子を標的	EGFR阻害薬 ゲフィチニブ エルロチニブ アファチニブ ダコミチニブ オシメルチニブ ラゼルチニブ アミバンタマブ
	ALK・ROS1阻害薬 アレクチニブ プリグチニブ ロルラチニブ クリゾチニブ エモトレクチニブ
その他の標的薬 希少ドライバー遺伝子・血管新生	BRAF・MET・RET・KRAS ダブラフェニブ テボチニブ カブマチニブ セルベルカチニブ ソトラシブ
	HER2変異(ADC) T-DXd 血管新生阻害薬 ペバシズマブ ラムシルマブ
免疫チェックポイント阻害薬 T細胞のブレーキを解除	抗PD-1抗体 ニボルマブ ペムブロリズマブ セミプリマブ 抗PD-L1抗体 アテゾリズマブ デュルバルマブ
	抗CTLA-4抗体 イビリムマブ トレメリムマブ

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 治療ラインの位置づけ(進行・再発)

対象	1次治療	2次治療	3次治療以降
EGFR変異陽性	オシメルチニブ(土プラチナ併用化学療法)、他のEGFR阻害薬	プラチナ併用化学療法(土ペバシズマブ)	ドセタキセル±ラムシルマブ 等
ALK融合遺伝子	アレクチニブ、ロルラチニブ、プリグチニブ	未使用のALK阻害薬(ロルラチニブ等)	プラチナ併用化学療法 等
ドライバー陰性 PD-L1 50%以上	免疫チェックポイント阻害薬単剤、または化学療法との併用	プラチナ併用化学療法	ドセタキセル±ラムシルマブ 等
ドライバー陰性 PD-L1 50%未満	プラチナ併用化学療法+免疫チェックポイント阻害薬(±抗CTLA-4抗体)	ドセタキセル±ラムシルマブ	S-1、ペメトレキセド(非扁平上皮) 等
小細胞肺癌 進展型	カルボプラチン+エトポシド+アテゾリズマブ/デュルバルマブ	アムルビシン、ノギテカン 等	全身状態に応じて選択

ROS1・BRAF・MET・RET・KRAS G12C・HER2変異は、それぞれ対応する標的薬を1次または2次治療で使用。局所進行期は化学放射線療法後にデュルバルマブで地固め療法を行う。

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	1か月	3か月	半年～
● インフュージョンリアクション	投与中～24時間					
● 悪心・嘔吐(シスプラチン)	～5日					
● 好中球減少(化学療法)		7～14日目				
● 皮疹・下痢(EGFR阻害薬)		服用1～2週から				
● 脂質異常症(ロルラチニブ)		開始数週で上昇				
● 爪囲炎(EGFR阻害薬)				1～2か月以降		
● irAE(甲状腺・肝・大腸炎等)				数週～数か月、終了後も		
● 間質性肺疾患				開始早期～数か月、時期を問わず		

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

- 非小細胞肺癌はドライバー遺伝子とPD-L1で1次治療が決まる「個別化医療」の代表
- 同じEGFR・ALK阻害薬でも世代で副作用が異なる(アファチニブ=皮膚・下痢、ロルラチニブ=脂質・中枢神経)
- ILD(咳・息切れ・発熱)はTKI・ICI・ADCに共通。薬局の聞き取りと病院の早期対応で守る